

Integração com a API Dental Office v1.0

Solicitação de credenciais e perguntas de contrato

Cliente: JP Clínica Odontológica
Responsável: Jeferson
Para: Suporte de API — Dental Office · api@dentaloffice.com.br
Data: 14 de setembro de 2026
Referência: especificação OpenAPI 3.0.3 publicada em apidocs.dentaloffice.com.br
Elaboração: equipe técnica da JP Clínica Odontológica

Contexto

A JP Clínica Odontológica contratou o desenvolvimento de um sistema próprio de relacionamento com pacientes, que consome a API pública v1.0 do Dental Office.

A implementação está **concluída e testada** contra a especificação OpenAPI 3.0.3 publicada por vocês, cuja cópia mantemos versionada junto do código — baixada em 09/09/2026. O que falta não é desenvolvimento: são as credenciais e um conjunto de confirmações que a especificação pública não responde.

Este documento reúne **17 perguntas**, organizadas por prioridade.

Parte	Assunto	Efeito de não responder
1	Habilitação e credenciais	Bloqueia tudo. Nada funciona sem isto.
2	Contrato técnico	Já implementamos sobre suposições. Uma resposta diferente do suposto exige correção.
3	Comercial, proteção de dados e mudanças	Não bloqueia hoje. Costuma custar caro depois.

Se puderem responder apenas a Parte 1, já conseguimos iniciar. As Partes 2 e 3 existem para não construirmos sobre suposição — um erro que já nos custou caro neste projeto, quando um conector inteiro foi escrito contra endpoints que imaginávamos existir.

PARTE 1 — Habilitação e credenciais

1. Habilitação da API

Solicitamos a habilitação da API pública v1.0 para a nossa conta.

- Existe **requisito de plano** ou contratação adicional para liberá-la?
- Esta solicitação parte do responsável pela clínica. Caso vocês exijam que ela venha por outro canal ou de outra pessoa cadastrada na conta, por favor nos informem — preferimos corrigir isso agora a descobrir depois de uma semana de espera.
- Qual o **prazo típico** entre esta solicitação e a entrega das credenciais?

2. As credenciais

Temos **uma unidade**. Precisamos de:

O que precisamos	Observação
URL base exclusiva da conta	Entendemos que é entregue já terminando em <code>/v1</code> .
<code>client_id</code>	
<code>secret</code>	Por qual meio vocês o entregam?
<code>clinic_id</code> da nossa clínica	Ver a nota abaixo — é o mais fácil de esquecer.

Sobre o `clinic_id`. Ele é parâmetro de caminho em `/clinics/{clinic_id}/schedules`, em `/clinics/{clinic_id}/schedules/available_hours` e nas demais operações de agenda.

Não localizamos nenhum endpoint que liste as clínicas da conta — portanto **não temos como descobri-lo do nosso lado**. E sem ele a autenticação funciona, a listagem de pacientes funciona, e toda a camada de agenda fica inoperante: é justamente dela que dependem recuperação de faltas, reagendamento de cancelamentos, confirmação de consulta e agendamento automático.

PARTE 2 — Contrato técnico

As perguntas desta parte correspondem a decisões que já estão escritas no nosso código. Indicamos, em cada uma, o que muda se a resposta for diferente do que supomos.

3. Rate limit — qual é o período?

A documentação diz: "A API possui um limite de **5.000 requisições** por período", e lista os headers `RateLimit-Limit` e `RateLimit-Remaining`. Ela **nunca define qual é o período**, e não há `RateLimit-Reset`.

Esta é a nossa dúvida mais importante. A diferença muda a arquitetura inteira: 5.000 por hora é folga larga; por dia, cabe apertado; por mês, inviabiliza sincronização frequente.

- Qual é o período?
- Existe header de reset? Se não, há previsão de incluí-lo?
- O que a API devolve ao exceder o limite — `429` ? Acompanhado de `Retry-After` ?
- O limite é contado por `client_id`, por clínica, ou por conta?

4. Paginação — `per_page` vale nos dois endpoints que mais usamos?

A introdução da documentação instrui: "Use os parâmetros `page` e `per_page`".

Porém, na lista de parâmetros, `per_page` aparece declarado apenas em `/customer_evolution`, `/disciplines`, `/schedule_reasons` e `/schedule_situations`.

Ele **não** aparece em `GET /customers` nem em `GET /clinics/{clinic_id}/schedules` — que são exatamente os dois que precisamos paginar em volume.

- `per_page` é aceito nesses dois endpoints?
- Qual o tamanho de página **padrão** e qual o **máximo** aceito?

Combinada com a pergunta 3, esta resposta decide se uma varredura completa de pacientes cabe dentro do teto de requisições.

5. Pacientes — não existe sincronização incremental?

Em `GET /customers` não encontramos filtro por data de atualização — apenas `q`, `page`, `clinic_id`, `active` e os filtros de exclusão (`only_deleted`, `deleted_start_date`, `deleted_end_date`). Confirmam?

Se confirmarem, toda varredura de pacientes é necessariamente completa. É isso que nos obriga a sincronizar pacientes uma vez ao dia, enquanto a agenda — que filtra por `start` e `end` — pode ser sincronizada com frequência. Se existir um filtro não documentado, ele muda substancialmente o nosso consumo de requisições.

6. Situação do paciente — existe endpoint que liste?

`GET /customers` devolve `customer_situation_id` como número. Não encontramos endpoint que liste as situações **de paciente** — existe `/schedule_situations`, mas é da agenda, não do paciente.

Hoje interpretamos pela tabela de fábrica: 1 primeira consulta, 2 em tratamento, 3 concluído, 4 alta, 7 abandono. Sem um endpoint, não temos como confirmar que a nossa clínica usa esses ids.

- Existe endpoint para listar as situações de paciente?
- Se não existir: os ids de fábrica são fixos, ou a clínica pode criar os seus?

7. Convênio — como resolvemos o nome?

`GET /customers` devolve `dental_insurance_id`, um número. O nome (`dental_insurance_name`) aparece apenas no paciente aninhado em outras respostas, e não localizamos endpoint que liste os convênios.

Existe endpoint para listar convênios? Hoje exibimos o número quando o nome não vem — o que chega à recepção como um dado sem significado.

8. Situações de agendamento — o `label` é estável?

Como `POST /schedule_situations` permite que cada clínica crie as suas, entendemos que o `schedule_situation_id` **não é estável entre clínicas**. Por isso lemos a situação pelo `label` (`to_confirm`, `absence`, `cancelled`), e não pelo número.

- Os labels das situações nativas são reservados e estáveis, ou a clínica também pode alterá-los?
- Na **escrita**, encontramos apenas o id numérico (`PATCH /clinics/{id}/schedules/{id}` com `schedule_situation_id`). Confirmam que não há como escrever pelo label?

9. Anotação — `obs` ou `note` ?

Ao criar agendamento via `POST /clinics/{clinic_id}/schedules` , a API aceita `obs` e `note` , e a resposta devolve `notes` . A especificação não diz qual dos dois alimenta `notes` .

Hoje escrevemos nos **dois campos** para não depender de palpite. Qual é o correto?

Não usamos `description` , porque observamos que vocês colocam ali o nome do paciente, para o calendário de vocês.

10. `available_hours` e criação de consulta

- Confirmam que `GET /clinics/{clinic_id}/schedules/available_hours` aceita apenas `dentist_id` e `next` (quantidade de dias a partir de hoje, padrão 9), **sem intervalo de datas**?
- Confirmam que o `chair_id` devolvido em cada horário livre é **obrigatório** no `POST` de criação?

Hoje descartamos qualquer horário que venha sem cadeira, para não oferecermos ao paciente um horário que quebraria no momento de confirmar.

11. Webhooks

Não encontramos webhooks na v1.0.

- Confirmam que não existem?
- Há previsão?

Sem eles, dependemos inteiramente de varredura periódica — o que nos devolve à pergunta 3.

12. Financeiro

Orçamentos, parcelas em aberto e pagamentos existem no produto Dental Office, mas não os localizamos na API v1.0.

- Confirmam que estão fora do contrato público?
- Há previsão de exposição?

Hoje isto é a diferença entre reportarmos receita conciliada e valor apenas estimado.

13. Ambiente de homologação, token e segurança

- Existe **ambiente de homologação** separado da produção, com credencial própria? Gostaríamos de validar a escrita na agenda sem tocar em dado real de paciente.
- **Token**: a documentação indica validade de 24 horas. Confirmam? Existe endpoint de renovação, ou repetimos `POST /auth/tokens` ?
- Há **restrição por IP** de origem? Nosso sistema roda em nuvem e não tem IP de saída fixo — se houver allowlist, precisamos saber antes de configurar.
- Qual o procedimento para **rotação do secret** ? E para **revogação imediata**, em caso de incidente?
- Existe canal para **incidentes de API** (indisponibilidade, erro sistemático)?

14. Criação de paciente

Pretendemos usar `POST /customers` para cadastrar automaticamente o paciente que hoje é digitado à mão.

- Quais campos são obrigatórios?
- Como a API trata **duplicidade** — mesmo CPF ou mesmo telefone? Devolve erro, ou cria um segundo registro?

PARTE 3 — Comercial, proteção de dados e mudanças

15. Custo e contrato

- O uso da API está **incluído no nosso plano atual**, ou é cobrado à parte?
- Se for cobrado: por requisição, por período, ou por volume contratado?
- Existe **termo de uso ou contrato específico** da API para assinarmos?

16. Proteção de dados

A integração vai trafegar **nome, telefone, data de nascimento e situação de tratamento** de pacientes para um sistema nosso, hospedado em nuvem.

- Os termos da API contemplam esse uso pela própria clínica, titular dos dados?
- Vocês disponibilizam **cláusula ou anexo de tratamento de dados** (LGPD) para esse cenário de integração?
- Quando um paciente solicita exclusão dos seus dados no Dental Office, **existe forma de a API sinalizar isso a quem integrou?**

A última é a que mais nos interessa na prática. Hoje enxergamos `only_deleted`, `deleted_start_date` e `deleted_end_date` em `GET /customers`, e queremos a confirmação de vocês de que é por esse caminho que devemos propagar exclusões.

17. Mudanças na API

Nosso conector foi escrito contra a especificação que baixamos em **09/09/2026**, e que mantemos versionada junto do código.

- Como vocês comunicam mudanças na v1.0? Existe changelog, ou lista de e-mail para quem integra?
- Qual a **política de depreciação** — quanto tempo de aviso antes de uma mudança que quebra integração existente?
- O documento em `apidocs.dentaloffice.com.br` é **versionado**, ou é sempre substituído pela versão vigente?

Como preferirem responder

Não é necessário responder em bloco. **A Parte 1 sozinha já nos destrava** — podemos iniciar a integração e seguir com as demais perguntas em paralelo.

Para as Partes 2 e 3, uma resposta numerada, mesmo que curta (*"confirmado"*, *"não existe"*, *"previsto para o próximo trimestre"*), já é suficiente para a nossa decisão.

Ficamos à disposição para qualquer informação que precisem do nosso lado. Se for mais prático, posso colocar vocês em contato direto com a nossa equipe técnica.

Atenciosamente,

Jeferson

JP Clínica Odontológica